

Amiodarone inj.

6 mg/2ml, amp

ข้อบ่งใช้



วันที่ปรับปรุง : ม.ค. 67

โดย: คกก.พัฒนาระบบยา
รพ.กรุงปิ่น

ข้อบ่งใช้ : Ventricular arrhythmias

ขนาดยาเริ่มต้นและการบริหารยา :

Cardiac arrest (VF/pulseless VT)

- ผู้ใหญ่: IV push ยา 300 mg+D5W 20-30 ml ให้ยาซ้ำๆ 3-5 นาที ให้ยาซ้ำได้ ภายใน 5 นาที ในขนาดยา 150 mg+D5W 20-30 ml สูงสุดไม่เกิน 2.1 g/24 hr การให้ IV push ต้อง Flush D5W 20 ml หลังจากนั้นยกแขนข้างนั้นขึ้นสูง 10-20 วินาที เพื่อให้ยา เข้าสู่หัวใจได้เร็วขึ้น

Ventricular tachycardia (stable)

24 ชั่วโมงแรก ให้ยา 1,050 mg โดยให้ตามลำดับ แบ่งเป็น 3 phases ดังนี้

- Rapid phase** ให้ยา 150 mg/3 ml (1amp) ใน D5W 100 ml อัตราเร็ว 30 mg/min ประมาณ 10 นาที >>>หลังจากนั้นให้ยา 900 mg (ผสม 6 amp = 18 ml ใน D5W 500 ml) โดยแบ่งการให้เป็น 2 ช่วง คือ
- Slow phase** แบ่งให้ยา 360 mg (ใน D5W 200 ml) IV drip ใน 6 ชม. (อัตราเร็ว 33 ml/hr) ต่อด้วย
- Maintenance phase** ให้ยาต่ออีก 540 mg (ใน D5W 300 ml) IV drip ใน 18 ชั่วโมง (อัตราเร็ว 17 ml/hr) หลังจาก 24 ชม. แรก ให้ Maintenance อัตราเร็วการให้ยาต่อจนอาการผู้ป่วยดีขึ้น อาจให้ infusion เสริมเมื่อมี recurrent arrhythmia ครั้งละ 150 มก. ซ้ำได้ ทุก 10 นาที หรือตามความจำเป็น แต่ไม่เกินขนาดสูงสุดวันละ 2.2 กรัม ไม่ต้องปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการทำงานของตับและไตผิดปกติ

การผสมยา: ห้ามผสมกับ NSS, Heparin, Aminophylline, Cefazolin, Furosemide

- ควรผสมให้ได้ความเข้มข้น ≤ 2 mg/ml และบริหารยานาน 1-2 ชั่วโมง (ความเข้มข้นสูงสุด 6 mg/ml)
- การให้ความเข้มข้น > 2 mg/ml ควรผสมยาในภาชนะบรรจุชนิดแก้วเท่านั้น เพื่อความคงตัวของยา และควรให้ยาทาง central line เท่านั้น

สารน้ำที่เข้ากันได้: D5W เท่านั้น

ความคงตัว: สารละลายเจือจางแล้ว บรรจุในภาชนะพลาสติก PVC มีความคงตัว 2 ชั่วโมง บรรจุในภาชนะขวดแก้ว หรือ POLYOLEFIN มีความคงตัว 24 ชั่วโมง

การติดตาม :

- HR, BP, RR >> ก่อนให้ยาฉีด, ทุก 15 นาที x 3 ครั้ง และต่อไปทุก 4 ชม.

อาการข้างเคียง :

- ความดันต่ำ
- หัวใจเต้นช้า
- prolonged QT interval
- hyper/hypothyroidism

แจ้งแพทย์เมื่อ :

- HR < 60 ครั้ง/นาที
- BP $< 90/60$ mmHg
- ECG พบ VT, VF, heart block